Клинические рекомендации

Рассеянный склероз

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**G35** — Рассеянный склероз **G36.9** — Острая диссеминированная демиелинизация неуточненная **G37.9** — Демиелинизирующая болезнь центральной нервной системы неуточненная
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 03.07.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Всероссийское общество неврологов; Национальное общество нейрорадиологов; Медицинская ассоциация врачей и центров рассеянного склероза и других нейроиммунологических заболеваний
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/739_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 2

2. Клиническая картина и классификация 2

2.1 Определение 2

2.2 Классификация 2

2.3 Клиническая картина 2

3. Диагностика 3

3.1 Магнитно-резонансная томография 3

4. Лечение 3

4.1 Терапия обострений 3

4.2 Медицинская реабилитация 3

5. Источник и актуальность 3

5.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 3

1. Основные положения

- Рассеянный склероз — хроническое демиелинизирующее заболевание с аутоиммунно-воспалительными и нейродегенеративными процессами, приводящими к множественному очаговому и диффузному поражению ЦНС.
- Поражение ствола мозга проявляется межъядерной офтальмоплегией, центральным нистагмом, дисфункцией отводящего нерва, гипестезией половины лица; менее характерны снижение слуха, невралгия тройничного нерва, периферический парез мимических мышц.
- Диагноз устанавливается прежде всего по клинической картине; МРТ головного мозга с контрастированием — дополнительный метод, но диагноз только по данным МРТ не ставят.
- Обострение у пациентов **с 18 лет** лечат метилпреднизолоном внутривенно в режиме пульс-терапии по 1000 мг **3–5 дней** (максимально 7).

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Рассеянный склероз (РС) — хроническое демиелинизирующее заболевание, в основе которого лежит комплекс аутоиммунно-воспалительных и нейродегенеративных процессов, приводящих к множественному очаговому и диффузному поражению центральной нервной системы, следствием которого является инвалидизация пациентов и значительное снижение качества жизни.

2.2 Классификация

Типы течения

1. **ремиттирующий** — обострения, между которыми не отмечается прогрессирование инвалидизации
2. **вторично-прогрессирующий** — после периода ремиттирующего РС, с подтверждённым прогрессированием инвалидизации, независимым от обострений
3. **первично-прогрессирующий** — заболевание дебютирует не с обострений, а с прогрессирования

2.3 Клиническая картина

Поражение ствола головного мозга

1. межъядерная офтальмоплегия;
2. нистагм (центральный);
3. дисфункция отводящего нерва;
4. гипестезия половины лица.

Менее характерны

1. снижение слуха;
2. невралгия тройничного нерва;
3. периферический парез мимических мышц;
4. лицевая миокимия.

Поражение мозжечка и его путей — статико-локомоторная и динамическая мозжечковая атаксия: неустойчивость при ходьбе, дисметрия и мимопопадание в координаторных пробах, интенционное дрожание, мозжечковая дизартрия (скандированная речь).

Поражение зрительного нерва — односторонний оптический неврит со снижением остроты зрения или скотомами, часто с болью при движении глазного яблока.

3. Диагностика

3.1 Магнитно-резонансная томография

Диагноз РС только на основании данных МРТ не ставят: он устанавливается прежде всего по характерной клинической картине, МРТ повышает точность и скорость диагностики.

Всем пациентам с подозрением на РС выполняется МРТ головного мозга с контрастированием — для исключения иной природы заболевания и оценки диссеминации в пространстве и времени.

4. Лечение

4.1 Терапия обострений

Препарат первого выбора у пациентов **с 18 лет** — метилпреднизолон внутривенно в режиме пульс-терапии по 1000 мг в течение **3–5 дней** (максимально 7).

4.2 Медицинская реабилитация

Пациентам с нарушениями речи и глотания показаны ранние комплексные логопедические процедуры при дисфагии и дизартрии, индивидуальная программа логопедической реабилитации, обучение компенсаторным стратегиям и альтернативным способам коммуникации.

5. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Рассеянный склероз»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 03.07.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2028 года
Код в рубрикаторе	739_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Медицинская ассоциация врачей и центров рассеянного склероза и других нейроиммунологических заболеваний; Всероссийское общество неврологов; Национальное общество нейрорадиологов
Пациенты	Взрослые и дети

5.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Клинически значимых противоречий в тексте рекомендации при сверке не выявлено.